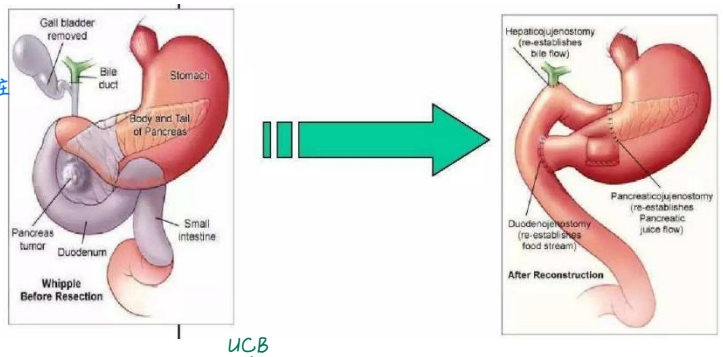
4.治疗

（1）**胰头十二指肠切除术 Whipple 术**。其并发症：

①胆肠吻合口漏、**狭窄**（可致胆管炎、肝脓肿）　消化液腐蚀作用　细菌排不走，逆行性到达肝脏

②**胰肠吻合口漏**（腹腔引流液淀粉酶明显升高）

③胃肠吻合口漏、反流



（2）胰腺远端联合脾切除（胰体尾癌）

内镜下支架置入、PTCD、胆/胃肠吻合（无法切除）　ERCP　经皮经肝胆管穿刺引流　减黄

放化疗，化疗药首选吉西他滨等（给姨弹个吉他）

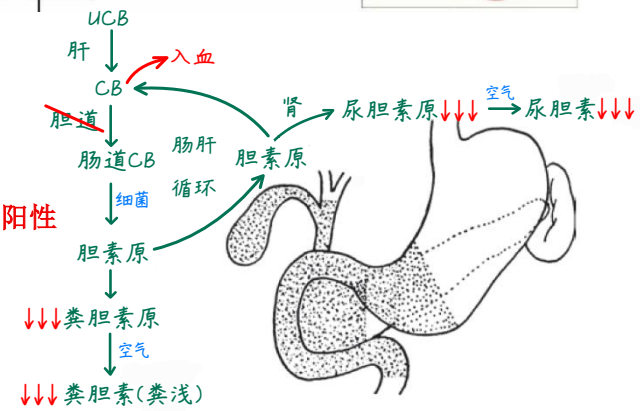
5.梗阻性黄疸

（1）特点

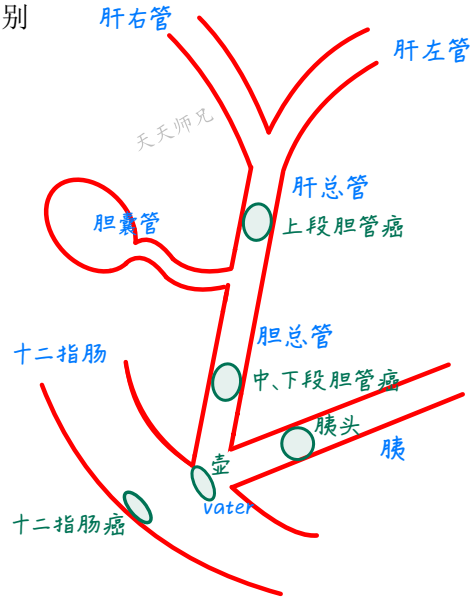
①**CB 显著↑**、CB/TB＞0.5、尿深呈浓茶样、**尿胆红素（尿 CB）强阳性**

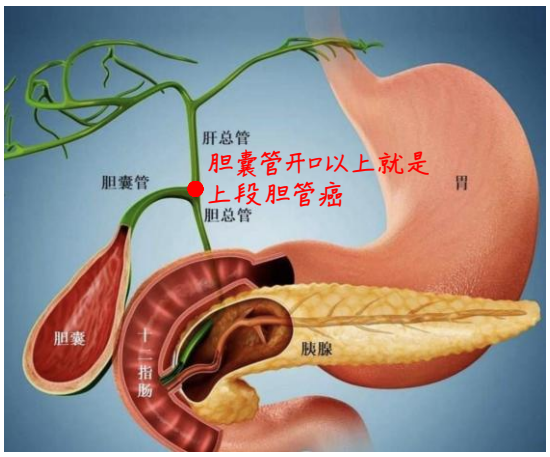
②尿/粪**胆素原↓**、粪浅甚至**白陶土样**　反映胆道梗阻　两极分化

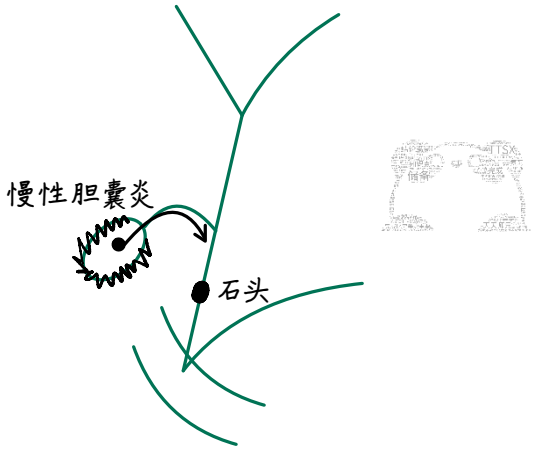
③**碱性磷酸酶 ALP↑**



（2）鉴别







	黄疸	胆囊
胰头癌	晚、进行性	大、不痛 courvoisier征
壶腹癌	早、进行性→减退→进行性(波动性)	大、不痛 courvoisier征
（恶性程度不大）十二指肠癌	晚、慢、浅	大、不痛 courvoisier征
上段胆管癌（肝门部胆管癌）	早、进行性	不大，可废用性萎缩
中下段胆管癌	早、进行性	大、不痛 courvoisier征
胆总管结石	炎症控制/消退 波动性黄疸 右上腹痛、寒战高热、Charcot征　疼黄烧	不大、可缩小、可大